今回のポイント（手術の順番）

後腹膜鏡下右腎尿管全摘除術（下部尿管：傍腹直筋切開）　2026年11月12日

腎摘パート（後腹膜鏡）

1. 外側円錐筋膜の切開

- 外側円錐筋膜は頭尾側に広く開く。

2. 腎周囲の剥離

- 頭側でまず剥離を進める。
- 一点突破しない（1か所だけ深く掘り進めず、周りを広く開けながら進める）。

3. 腎茎部・血管周囲

- 血管の近くの剥離はメリーランドで行う。

尿管処理パート（傍腹直筋切開）

1. 皮膚切開・皮下

- 皮切はもっと深く入れてよい。
- 脂肪はつまんで切っていく。

2. 腹直筋前鞘

- 腹直筋前鞘は1か所切開を入れ、そこから剥離して広げる。
- コッヘルで掴むときは、必ずその膜と下（の層）を剥離してから掴む。これは御作法。

3. 腹横筋筋膜・後腹膜腔

- 腹膜の手前に、非常に薄い腹横筋筋膜がある。
- 腹膜に寄らないように腹横筋筋膜を割ると、そこが後腹膜腔。用手的に剥離できる。

4. 尿管の剥離（膀胱まで）

- 尿管の背側には流入血管があり、それをリガシュアで処理しながら膀胱まで剥離する。
- 膀胱までの途中に、臍ひだと上膀胱動脈がある。

5. 膀胱カフ（ブラダーカフ）

- 膀胱まで来たら、膀胱漿膜・筋層などを剥離して、尿管を粘膜のみぐらいにする。そうするとブラダーカフが立ち上がる。

6. 尿管の離断（今回の方法）

- 弱彎ケリーと直角（鉗子）の2本で尿管を噛み、その間をメッツェンで切る。
- 下側（膀胱側）を貫通結紮し、膀胱漿膜を縫い合わせて終わり。

7. ドレーン

- J-VACは6.5cm（19Fr）。
- ドレーンを通すときは筋膜を貫通させる。

8. 閉創（1-0 PDS）

- 1-0 PDSは2回使える。
- 1回目は針をつけたまま片手で結紮する。
- 針側の糸は、もう一度使えるように確保しておく。
- 針側の糸の長さは、もう一度切る必要がないぐらいまで残す。